

ACTIVIDADES FUNCIONALES

SEMANA 10

BIOMECÁNICA CLÍNICA DE LAS ALTERACIONES EN LA C.V. II



Presente.

Lic. Kevin Tejada Cuadros

ESTENOSIS LUMBAR

- Se produce cuando los espacios en la columna vertebral se reducen y ejercen presión en la médula espinal y raíces nerviosas.
- El estrechamiento se produce a lo largo del tiempo.
- La posibilidad de presentar el trastorno aumenta a medida que la persona envejece.
- Puede darse en jóvenes que nacen con un conducto vertebral reducido o que sufren una lesión en la columna lumbar.



SÍNTOMAS

- Dolor en el área lumbar de la espalda.
- Dolor o ardor que se extiende a los glúteos y las piernas, y que generalmente empeora al ponerse de pie o caminar, y mejora al inclinarse hacia adelante.
- Adormecimiento, hormigueo o calambres en las piernas y los pies que pueden empeorar al ponerse de pie o caminar.
- Debilidad en las piernas y los pies.

Síntomas

Claudicación de la marcha



Dolor que empeora con la actividad física.



Irradiación del dolor en miembros inferiores.



CAUSAS

- El envejecimiento y los cambios en la columna vertebral relacionados con la edad ocurren con el tiempo y lentamente ocasionan estenosis espinal.
- La artritis es otra causa frecuente de la estenosis espinal. Dos formas de artritis que pueden afectar la columna vertebral son la osteoartritis y la artritis reumatoide.
- Otras afecciones como tumores en la columna vertebral, fracturas por lesiones u otros problemas médicos y la enfermedad ósea de Paget también pueden causar estenosis espinal.

¿CÓMO SE TRATA?

- Tratamientos no quirúrgicos, que pueden aliviar el dolor e incluyen fisioterapia, un aparato ortopédico para brindar apoyo.
- Medicamentos para ayudar a aliviar el dolor y la inflamación.
- Cirugía, según los síntomas, cómo responde a otros tratamientos y el estado general de salud.



SACROILEITIS

- Dolor producido en la articulación sacro-ilíaca, generada por factores de estrés mecánico.
- Es una causa subdiagnosticada del dolor lumbar crónico no radicular, que afecta entre el 15% y 30% de los casos.



ETIOLOGÍA

- Los mecanismos de daño son por la combinación entre carga axial y rotación, siendo la ASI más vulnerable que la columna lumbar a ambas.
- La mitad de las causas son idiopáticas o por microtrauma, debidas a excesiva tensión de los ligamentos que aseguran la coaptación ASI, dolor por estrés mecánico de la cápsula y ligamentos de la ASI durante el embarazo, actividades deportivas o fusión lumbosacra.

Intraarticular

Artritis: reumatoide y psoriática

Pelviespondilopatías

Cáncer

Trauma

Infección: estafilococia,
brucelosis, tuberculosis

Enfermedad quística

Extraarticular

Lesión ligamentosa

Fracturas óseas

Cáncer

Dolor miofascial

Entesopatía

Trauma embarazo

ETAPAS

ETAPA AGUDA: 1 – 3 DÍAS	El manejo incluye reposo relativo, aplicación de hielo/ movilización con calor, antiinflamatorios no esteroideos.
ETAPA DE RECUPERACIÓN: 3 DÍAS – 8 SEMANAS	El tratamiento consiste en movilización articular y terapia física.
ETAPA DE MANTENCIÓN	Tratamiento dirigido a corregir la dinámica postural. Una vez que el dolor ha cedido, intentar restaurar la mecánica normal.

TRATAMIENTO REHABILITADOR

Los objetivos de la terapia física son:

- Aliviar el dolor, eliminando sus generadores.
- Aumentar la coaptación y estabilidad ASI, fortaleciendo la musculatura del cuádriceps, abdominales, isquiotibiales.
- Mejorar déficits de flexibilidad, propiocepción, fuerza y problemas biomecánicos; desbalances mal adaptativos, corrigiendo los mecanismos lumbo-pélvicos y de cadera.
- Mejorar control postural dinámico.
- El programa de ejercicios diseñados para aliviar el dolor y corregir los problemas biomecánicos debería ser titulados individualmente. El único punto validado en kinesiterapia es tener cuádriceps, abdominales e isquiotibiales bien desarrollados, necesarios para asegurar la coaptación y estabilidad de la articulación sacroilíaca, y que ellos controlan activamente.





Gracias por su
atención